

デジタル時代のナラティブ・メディスン

物語の力 x 臨床思考 x デジタルツールの統合

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

最近診た患者さんの中で、病歴だけでは
捉えきれなかった「何か」を感じた経験はありますか？

この 30 分の後、あなたは：

- ナラティブ・メディスンの理論的背景を説明できる（理解）
- デジタル・ナラティブの可能性と限界を論じられる（分析）
- 臨床思考との統合アプローチを 1 つ導入する計画を立てられる（創造）

ナラティブ・メディスンとは

Rita Charon のフレームワーク（Columbia, 2001）

要素	意味	臨床での実践
Attention	注意深く聴く	患者の語りに意識を向ける
Representation	物語を表現する	聴いたことを言語化・記録する
Affiliation	繋がりを形成する	患者との治療的関係を深める

ナラティブ・メディスン = 患者の物語を医療の中核に据えるアプローチ。
「聴く→表現する→繋がる」の3つのステップで、医師 - 患者関係を深める。

ナラティブ教育の現実 — 4つの構造的障壁

Frontiers in Medicine, 2026

☒ カリキュラム過密

ナラティブ教育の時間確保が困難

☒ 教員の準備不足

ナラティブを教えるトレーニングが未体系化

☒ 評価方法の不整合

ナラティブ能力をどう測定するか未解決

☒ 長期アウトカム研究の不足

ケアの質・燃え尽き防止への効果が未検証

構造的な障壁を無視すると形骸化する — システム思考で「レバレッジポイント」を見極めよう

デジタル・ナラティブ・メディシンの登場

JMIR, 2026 — デジタルがナラティブを拡張する 3 つの方向

患者 エンパワーメント

共同設計（co-design）
患者参加型ケア
アドボカシー

ケアチームの 人間化

物語のデジタル可視化
カルテを超えた記録
人間化の架け橋

教育への応用

AI 構造化分析
共感教育の支援
臨床推論との統合

限界： デジタルデバイド | プライバシー | 構造化が物語の豊かさを損なうリスク

ナラティブ x 臨床思考の統合

BMC Medical Education, 2025 — 神経内科での実証

項目	内容
方法	ナラティブ + 臨床思考 vs 従来教育
結果	統合群が有意に高い学習成果
意味	ナラティブと臨床思考は相補的

統合モデル概念図

患者の物語
↓ Attention
物語の構造化
↓ 臨床思考モデル適用
仮説生成 ↔ パターン認識
↓ Affiliation
統合的臨床判断

批判的吟味

- Study Design: 単施設、サンプルサイズは？
- 「高い学習成果」の測定方法は適切か？
- 一般化可能性と教育者効果の交絡は？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場で、ナラティブ x 臨床思考 x デジタルツールの統合を 1 つ実践するとしたら、何ができるか？

考えるヒント

- 外来の問診にナラティブの要素を 1 つ追加するなら？
- カンファレンスで「患者の物語」を構造的に共有する方法は？
- デジタルツール（音声記録、テンプレート等）をどう使えるか？

3つの論文が示す全体像

論文	視点	あなたの臨床に
Frontiers	理想と障壁	現場の制約を知って設計
JMIR	デジタルの可能性	障壁を突破するツール
BMC	統合の実証	物語 + 構造が効くエビデンス

来週までの1アクション（1つ選ぼう）

- 患者の語りに3分間、中断せず耳を傾けてみる
- カルテ「現病歴」に患者の言葉を1文そのまま記載
- 同僚と「心に残った患者の物語」を1つ共有

持ち帰りの問い：デジタルツールが「記録」を便利にする一方で、
聴く力そのものはテクノロジーでは代替できない。
デジタル時代に「聴く力」をどう育むか？